LIMES
SCHLOSSKLINIKEN

Limes Schlossklinik Rostocker Land GmbH
Gutshofallee 1; 17166 Teterow/Teschow

An den weiterbehandelnden Arzt

Limes Schlossklinik
Rostocker Land GmbH
Chefarzt Arne Kresin
Gutshofallee 1
17166 Teterow/Teschow

Tel.: +49 (0) 3996 – 140 140
Fax: +49 (0) 3996 – 140 481
E-Mail: kontakt@limes.care
www.limes-schlosskliniken.de

Teschow, den 05.11.2018

Entlassungsbericht

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

wir berichten über unseren gemeinsamen Patienten Herrn Christian Brand, geboren am 27.05.1978, der sich vom 15.07.2018 bis 31.10.2018 in unserer stationären Behandlung befand.

Diagnosen:

F33.2	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome

Aktuelle Anamnese und Aufnahmeanlass: Seine Gesundheit sei angeschlagen: In den letzten Wochen und Monaten sei er infektanfällig gewesen, Erkältungen u.s.w. hätten ihn beschäftigt, er habe sich nicht wie in gewohnter Weise über seine sportliche Betätigung regenerieren können. Erholung finde nicht statt: Seine Eltern seien krank und allein, er habe für drei Kinder (6,8, 12 Jahre alt), zu sorgen, arbeite im Schichtdienst. Er empfinde Kraftlosigkeit, Antriebslosigkeit, habe überwiegend negativ empfundene Tage, Schlafprobleme, wisse derzeitig nicht, wie es für ihn weitergehe, sowohl beruflich, als auch privat. Er habe viele unbeantwortete Fragen, die ihn sehr belasten. Zudem erlebe er sich grüblerisch, rationalisierend, depressiv und erlebe schnell Schuldgefühle und hohes Verantwortungsgefühl.

Aktuelle Lebenssituation: es besteht Arbeitsunfähigkeit seit Mai 2018. Herr Brand ist Polizei - Oberkommissar bei der Schutzpolizei und arbeitet in Wechselschichten, aktuell ohne Nachtarbeit (Habe er nicht mehr leisten wollen und können). Er ist verheiratet und hat drei Kinder im Alter von 6, 8 und 12 Jahren. Eine vorübergehende Trennung von der Ehefrau sei im Jahr 2014 erfolgt, jedoch sei er aus „Vernunftgründen" wieder zur Familie zurückgekehrt. In diesem Zusammenhang habe er erstmalig 2015 Psychotherapeutenkontakt in Anspruch genommen. Er sei damals „tief gefallen" aus verschiedenen Gründen, habe unter einer ausgeprägten depressiven Symptomatik gelitten mit Antriebslosigkeit, totaler Erschöpfung, Freudlosigkeit, Interessenlosigkeit, geringem Selbstwert, Versagensängste. Diese Episode sei mit Gesprächstherapie mit gutem Erfolg behandelt worden.

Jetziger Auslöser sei eine geplante berufliche Veränderung als einmalige Chance gewesen: Im Team einer Verhandlungsgruppe-zwischengeschaltet zwischen SEK und Täter/Opfer als verbale Vermittler-mitzuarbeiten. Zunächst lief das Projekt gut an und nach den Testverfahren wurde Hr. Brand als geeignet befunden. In der Probezeit sei ihm jedoch nach 5-6 Wochen mitgeteilt worden, er passe „vom Typ" her nicht. Sehr große Enttäuschung folgte- er habe zu viel eingesetzt an Kraft und Zeit. Der aktuelle Dienststellenleiter sei persönlich auch enttäuscht gewesen-mit der Folge, dass er ihn zunächst nicht habe zurücknehmen wollen im Falle des Scheiterns, jedoch in der jetzigen Situation diese Entscheidung habe revidieren wollen. Jedoch saß die erste Aussage noch als Enttäuschung sehr tief, so dass er sich darauf bisher nicht einlassen wollte. Zunächst habe er sich freistellen lassen. Er wolle sich allerdings verändern-andere Tätigkeit im Polizeiapparat aufnehmen. Ferner würden ihn familiäre Probleme weiterhin belasten: zum einen die Sorge und Verantwortung für seine erkrankten Eltern, die getrennt leben. Die Mutter habe er in seine Nähe ziehen lassen. Mit in seinem Haus lebe sein Bruder, der gegenwärtig depressiv sei und unter einer Borderline-Störung gelitten habe.

Psychiatrische Anamnese: Ab Januar 2015 ambulante Psychotherapie (vermutlich tfP) mit ca. in den ersten drei Monaten wöchentliche stattfindenden Terminen. Dann folgte eine Phase einmal monatlicher Therapie. Die Verlängerung der Abstände resultierte aus einer terminlichen Problematik, da der Patient im Schichtdienst arbeitete und der Therapeut nur an zwei Tagen in der Woche in Deutschland war und sonst in der Schweiz verweilte. Eine erneute Intensivierung der ambulanten Psychotherapie erfolgte vor kurzem. Bisher keine stationäre psychiatrische oder psychosomatische Behandlung.

Medikamentenanamnese: Im Jahr 2014 erfolgte erstmalig kurz eine Einnahme eines Antidepressivums. Diese wurde bei fehlender Wirksamkeit zeitnah verlassen. Seit Mai 2018 Einnahme von Valdoxan. Konsekutiv sei der Schlaf durchgängiger geworden.

Medikation bei Aufnahme: Valdoxan 25 mg 1-0-1-0, personifiziertes Hormonpräparat mit individuellen Dosen aus Estradiol, Progesteron, sowie Zinkgluconat und Kupfergluconat 1-0-1 seit 09.07.2018

Biographische und soziale Anamnese: Kann sich an viele Stellen seiner Kindheit nicht erinnern. Vermutet wegen vorangegangener Behandlung eine Idealisierung seinerseits jener Zeit. Trennung der Eltern als er 15 Jahre alt war, Scheidung drei Jahre später. Lernte seine heutige Frau schon damals kennen und begann eine Beziehung mit ihr. Beschreibt wenige Sozialkontakte und hohe Ideale/ Werte an Freundschaften.

Familienanamnese: Vater: M. Crohn, häufige Operationen und KH-Aufenthalte, getrennt von der Ehefrau. Mutter: Lungenkrankheit (Mykose)-Mitte 2014, 1 Lungenflügel entfernt-nach massivem Kortison Einsatz Osteoporose. Mutter lebt am gleichen Ort. Bruder (-5) stark depressiv, Z.n. Borderline-Störung, lebt mit im Haus des Patienten.

Mittelanamnese: Nichtraucher; sehr gelegentlich Alkohol, Drogenkonsum generell verneint.

Somatische Anamnese: Kinderkrankheiten: Mumps, Masern, Röteln, Scharlach, Pseudokrupp und Windpocken, Früher gehäuft Sinusitiden. Operationen: AE; 5-6 Operationen an beiden Knien (Fußball, Skilaufen) zuletzt 2015; Klaviculafraktur links-operativ versorgt; ein Jahr lang auf Kohlenhydrate, Gluten und diverse andere Lebensmittel verzichtet (nach Hinweisen aus einer Analyse), Schritt um Schritt wieder

eingeführt, meidet aktuell übermäßig Gluten in der Ernährung. Vegetative Anamnese: Appetit normal; Gewicht stabil; Schlaf gebessert unter Valdoxan; Stuhlgang und Miktion unauffällig. Allergien und Unverträglichkeiten liegen nicht vor.

Körperlicher Untersuchungsbefund: 40-jähriger Patient im geschwächten AZ, erschöpft wirkend, Habitus sportlich trainiert, gutem EZ, Körpergröße 179 cm, Gewicht 78,0 kg, 24,3 kg/m^2. Kein Fötor. Haut und Schleimhäute gut durchblutet. Kopf frei beweglich, kein Meningismus, kein Kalotten-KS, keine zervikalen LK vergrößert tastbar. NNH frei. Zahnstatus intakt, saniert. Rachen und Mundhöhle reizlos. SD nicht vergrößert. Thorax symmetrisch, sonorer KS. vesikuläre AGs bds. Seitengleich. Herztöne rein. RR 120/80 Puls 50/min. Bauchdecken weich, Darmgeräusche lebhaft, kein DS, keine pathologischen Resistenzen. NL bds. frei. Leber und Milz nicht vergrößert tastbar. Extremitäten unauffällig. Keine Varikosis, keine Ödeme. Normale Beweglichkeit der Gelenke.

Neurologischer Untersuchungsbefund: Visus intakt. Konjunktiven unauffällig. Pupillen mittelweit, isokor rund, reaktiv auf Licht und Konvergenz. Riechen, Schmecken seien subjektiv beeinträchtigt. Hören unauffällig Keine Parese, keine Sensibilitätsstörungen, Muskeleigenreflexe gut und seitengleich auslösbar. Keine pathologischen Reflexe. Kein Absinken in den Halteversuchen. FBA 0 cm. Romberg, Seiltänzer, Einbeinstand, Zehen- und Hackengang, FNV, Knie-Hacken-Versuch uneingeschränkt durchführbar.

Psychometrischer Befund: Bei Aufnahme und Entlassung wurden klinische Testverfahren durchgeführt. Symptom-Checkliste SCL-90-R: Die SCL-90-R erfasst mit Hilfe von 90 Items die gegenwärtige psychische Belastung einer Person auf symptomatischer Ebene. Gemäß Falldefinition liegt bei Herr Brand zum Aufnahmezeitpunkt deutlich ein klinisch relevanter Fall von psychischer Belastung vor (globale Werte: T[GSI] = 71, T[PST] = 65, T[PSDI]=61). Die Analyse der neun Skalen ergab stark erhöhte T-Werte auf den Skalen Somatisierung (T=62), Zwanghaftigkeit (T=80), Unsicherheit im Sozialkontakt (T=63), Depressivität (T=68), Aggressivität (T=65) und Psychotizismus (T=66). Beck-Depressions-Inventar BDI-II: Das BDI-II ist ein Selbstauskunftsfragebogen zur Erfassung der Schwere depressiver Symptome. Bei Aufnahme wurde ein klinisch relevanter Summenwert von 31 erreicht, der auf eine schwere Ausprägung depressiver Symptome hindeutet.

Psychopathologischer Befund: Erscheint pünktlich, wach, sportlich gekleidet. Zu allen Qualitäten orientiert. Stimmung zum depressiven Pol neigend. Affektiv abgeflacht, eingeschränkt schwingungs- und modulationsfähig. Aussprachebereit und hilfesuchend. Antrieb gemindert. Formalgedanklich geordnet. Hofft auf Antworten bezüglich beruflicher Orientierung und Umgang mit privaten Themen, partnerschaftlich und familiär. Kein Anhalt für Sinnestäuschungen, inhaltliche Denkstörungen und Ich-Störungen. Nicht suizidal. Tendenz zur Perfektion und Genauigkeit mit partieller Prokrastination. Dem Patienten ist die Thematik um die eigene Unabhängigkeit wichtig. Repetitiv konturierte sich die Thematik um die „emotionale Passung", die wichtige Grundlage für das berufliche Miteinander sei, da der Patient „vieles aus dem Bauch heraus" entscheide.

Therapieziele: Erarbeitung eines individuellen Krankheitsmodells; Beleuchtung krankheitserhaltender Faktoren und deren Aufweichung; Steigerung der Selbstfürsorge; Verminderung der Belastung durch die versorgende Rolle im Familiensystem; Erarbeitung besserer Möglichkeiten zu Abgrenzung, weitere psychopharmakologische Betreuung und ggf. weitere Modifikation der Medikation und physiotherapeutische Behandlung.

EKG- und Laborbefunde in Kopie anbei.

Therapie und Verlauf: Die stationäre Aufnahme erfolgte bei o.g. Anamnese. Unser stationäres Angebot beinhaltet eine umfassende Diagnostikphase und die Integration in ein multimodales Behandlungskonzept mit erhöhter Facharztpräsenz. Wir bieten eine intensive einzel- und gruppentherapeutische Behandlung, welche verbale und nonverbale (Ergo-, Kunst-, Tanztherapie), sowie individualisierte Sporttherapien umfasst. Zudem erfolgen Chefarztgespräche, sowie fachärztliche Gespräche. Zu Beginn stand zunächst die supportive und ressourcenfördernde Behandlung sowie die Erarbeitung individueller auslösender und aufrechterhaltender Faktoren im Vordergrund. Dazu gehörte der Aufbau einer therapeutisch tragenden Beziehung, die es ermöglichte, sich auf einen therapeutischen Prozess im Sinne der vereinbarten Therapieziele einzulassen, um eine hinreichende Stabilisierung für eine ambulante Weiterbehandlung zu erreichen.

Herr B. konnte sich zügig und erwartungsvoll auf unser multi-modales hochfrequentes Therapiesetting einlassen und schon beginnend von dem Programm profitieren. Auch kann er sich offen auf therapeutische Beziehungen einlassen und selbst-reflektiert, wohl auch aufgrund der stattgehabten amb. Psychotherapie, in biografische Aufarbeitung einsteigen. Dahingehend zeigt sich, dass er durch die Trennung der Eltern im Alter von 14 Jahren, zu früh die Verantwortung für die Familie übernahm und eine hoch-ambivalent negative Beziehung zu seiner depressiven Mutter aufgebaut hat. Durch die jüngsten Versagenserfahrungen wie beruflicher Misserfolg, Schulden durch Autokauf, haben sich beim ihm ausgeprägte Schuldgefühle aufgebaut. Zudem fällt es Herrn B. äußerst schwer, seine versorgende bis hin zu therapeutische Rolle im Familiensystem zu verändern, kommt aber dadurch in der Selbstfürsorge zu kurz. Herr B. befindet sich weiterhin in einem fruchtbaren therapeutischen Prozess, bleibt dabei aber depressiv bei abgewehrter Emotionalität und innerer Leere, die ihn sehr beeinträchtigen.

Erste Bewegung hinsichtlich des Erspürens und intrapsychischen Erkennens von Wut-Affekten werden deutlich. Diese lassen einen positiven Schritt hinaus aus der Gefühlslosigkeit erkennen. Diese ist gebunden an die Primärobjekte und kann noch nicht ohne direkt anschließende Rationalisierungen erlebt und benannt werden. Die depressiven Muster der Eltern geben deutliche Anzeichen für erlernte nonverbale Kommunikation des Patienten durch die Symptomatik hindurch. So zeigen sich bei den Eltern Tendenzen zur Einforderung von Versorgung und Bestrafung des Selbst und der Objekte mittels depressiver Muster, welche sich beim Patienten ebenso abzeichnen. Erste Bemühung zu emotionalem Kontakt zum Vater wurden unternommen, doch verliefen nicht fruchtbar, was Herrn B. kurzfristig in seiner Hoffnungslosigkeit bestätigte und zurück in die krankheitserhaltende fremdversorgende Rolle rutschen ließ.

Die psychopharmakologische Medikation mit Valdoxan wurde zunächst fortgeführt. In der Phase der Eingewöhnung wurden regelmäßig die Kreislaufparameter erhoben. Es wurden begleitend die Entspannungsverfahren autogenes Training und Yoga verordnet. Zur Verbesserung der Schlafsymptomatik wurde die edukative Gruppe Schlaf ordiniert. Von somatischer Seite wurde das Programm ergänzt durch eine physiotherapeutische Behandlung, und eine Herzfrequenzvariabilitätsmessung durchgeführt. Es erfolgte eine Umstellung der psychopharmakologischen Medikation und es wurde Tianeptin ordiniert insbesondere

im Kontext der Stressachse. Wir empfehlen eine weitere ambulante psychiatrische Behandlung und psychopharmakologische Begleitung. Des Weiteren empfehlen wir die Kontrolle der Cholesterinwerte und ggf. bei persistierende erhöhten Cholesterinwerten eine entsprechende Medikation.

Herr Brand kam kleinschrittig abgeschnittenem Gefühlserleben näher. Nichtsdestotrotz blieben die unbewussten Bewältigungsmuster noch aktiv, welche ihn jedes Mal erneut von sich selbst abtrennten. Eine körpertherapeutische Einzelbehandlung sollte diesem Erleben weitere Verarbeitungskanäle für den Zugang bieten. Chefärztliche Mitbehandlung, wurde zusätzlich begonnen. Herr Brand konnte in Belastungserprobungen erste Schritte zurück in den heimischen Alltag erproben. Noch ist dabei das gewohnte Beziehungsmuster aktiv mit einhergehender subjektiver Insuffizienz, negativistischer Selbstwahrnehmung und Weltsicht. Der Verlauf ergab eine „Erschöpfung vom Denken" bei Herrn Brand. Kurz darauffolgend ergaben sich für ihn Reinszenierungen seiner Biografie in der Gegenwart. Damit verbunden konturierte sich zunehmend die Symptomatik einer agitierten Depression. Kognitive Stressmodelle gestalteten einen weiteren Zugang zum inneren Erleben, perspektivisch hin zu einer akzeptierenden Position. Thematisch schneiden die Gespräche regelmäßig Selbstwert, Wunsch nach Nähe, Bedürfnis nach Schutz, übersteigerte Ideale an sich und andere an.

Im letzten Behandlungsabschnitt fand Herr Brand schrittweise u.a. durch chefärztliche Hilfestellung einen Weg zur Akzeptanz, teils mit Unterstützung eines Paargespräches. Dies eröffnete ihm in guten Ansätzen einen Zugang zu einer hoffnungsvolleren perspektive sich selbst bezüglich. Weitere eigene Anteile am Behandlungsverlauf wurden von ihm in dieser Zeit erkannt und benannt. Weiter im Fokus der Behandlung könnten unteranderem die Selbstwerthomöstase und der Aspekt der Ambivalenztoleranz sein.

Wir entlassen Herrn Brand teilstabilisiert in das häusliche Umfeld auf eigenen Wunsch. Als Empfehlung sehen wir eine weitere ambulante Therapie zur zusätzlichen Stabilisierung als notwendig. Im Falle einer erneuten Exarzerbation stehen wir Hr. B. gerne zur Verfügung.

Entlassungsmedikation: Tianeurax 12,5 mg 1-1-1

Mit freundlichen Grüßen

Arne Kresin
Chefarzt Limes Schlossklinik Rostocker Land
FA f. Psychiatrie und Psychotherapie
FA f. Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
Suchtmedizinische Grundversorgung

Michael Barth
Oberarzt
FA f. Psychosomatische Medizin und Psychotherapie